リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月17日（土）

第37号 朝刊

■ 整形・栄養

大腿骨近位部骨折後の栄養補助12週 再入院31%対47%、ITTは差なし

デンマークRCTの二次解析。差が出たのは実際に飲めた人の解析のみ

デンマークのコペンハーゲン大学病院のRCTの、事前計画された二次解析。栄養リスクのある65歳以上の大腿骨近位部骨折患者を、ビタミンDとオメガ3入りの高エネルギー・高たんぱく栄養補助（1日2缶）を退院後12週とる群と通常ケア群に割り付け、38週の死亡と再入院を比べた。

死亡は2人（3%）対3人（5%）で差がなかった。再入院は介入群19人（31%）、対照群29人（47%）で、ITT解析のRRは0.72（95%CI 0.51～1.03、p=0.075）と有意に届かず、実際に飲めた人のper-protocol解析では18%対44%（RR 0.69、0.52～0.92）だった。頻度、在院日数、初回再入院までの期間に差はなかった。

小規模で、有意だったのは継続できた人の解析のみ。「飲めた人ほど良かった」には選択の偏りもありうる。退院後の栄養支援を続ける体制の根拠としては、まだ傾向止まりと受け取るのが妥当だ。個別の状態の確認が前提だ。



再入院は減る傾向。ただしITTでは有意でなく、小規模。

出典 Clin Rehabil ↗

数字で見る

31%
介入群の再入院

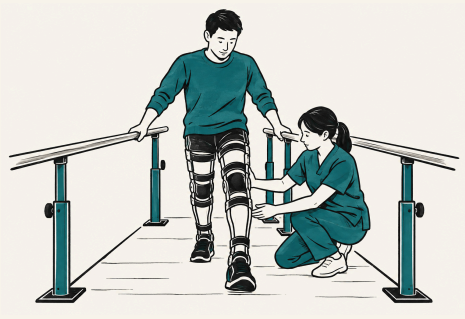
47%
対照群の再入院

0.72
ITTのRR（0.51～1.03）

■ 脳卒中・装具

長下肢装具の回復期脳卒中103例 6か月歩行は年齢・運動FIM・入棟日数

回復期病棟で長下肢装具を使った歩行練習を行った脳卒中103例を後ろ向きに調べた。発症6か月以内の歩行能力で歩行可能群50例と歩行介助群53例に分け、入院時の基本属性、身体機能、ADL、高次脳機能障害、理学療法の平均単位数を比べ、多重ロジスティック回帰を行った。



関連が示されたのは年齢、FIM運動項目、発症から入棟までの日数で、カットオフ値は70歳、24点、27日。後ろ向きの1報告で外部確認は抄録から分からず、「27日を過ぎたら難しい」とは読めない。方針を考える際の参考材料の一つとして使いたい。

出典 総合理学療法学 6巻 ↗

■ 上肢・在宅

慢性期脳卒中の腕、在宅訓練MINT 3筋群の群でWMFTが6週で6.8秒短縮

中等度～重度麻痺の慢性期脳卒中を、2～3筋を別々に動かすゲームを行う3つのMINT群とsham群に割り付け、1日90分・週6日で訓練した。59人が完遂し、WMFTは3筋群が6週で6.8秒改善（95%CI 2.1～11.6、P=.001）。他の群は有意でなく、per-protocolのsham比は7.5秒（0.1～14.9、P=.046）だった。



共収縮の減少は機能の改善と相関したが、内包にかかる病巣は反応が悪く、他の副次評価に重要な変化はなかった。人数が少なく、毎日90分を6週続けられた集団の結果である点に注意したい。

出典 Neurorehabil Neural Repair ↗

短信

〈サルコペニア〉 **改善は入院時運動FIMと関連**
回復期のサルコペニア87例。退院時に改善した群で入院時運動FIMが関連。 出典 理学療法学 ↗

〈Pusher〉 **トイレ動作の改善要因は段階で違う**
Pusher現象9例。2人介助まで中央値7日、1人介助は6例で中央値13日。 出典 理学療法科学 ↗

〈PD〉 **地域在住PD患者はIADLが少ない傾向**
PD26名と高齢者40名の予備研究。屋外家事・趣味が少なく作業剥奪と相関。 出典 作業療法 ↗

〈予後予測〉 **1か月データで上肢予測が向上**
脳梗塞353人。上肢予測でAUC0.889→0.990（p=0.037）。他は有意差なし。 出典 J Clin Med ↗

〈機器〉 **入院中の自主トレ機器を整理**
18研究1,081人。上肢ゲーム・ロボット・動画アプリ中心。有効性は限定的。 出典 Clin Rehabil ↗

〈予後予測〉 **脊損の歩行予測ML**
脊損148人で作成、37人で検証。内部AUC0.91、外部の再現率0.70。探索的。 出典 Neurorehabil Neural Repair ↗

〈バランス〉 **Mini-BESTと敏捷性は相関**
リハ利用者31名。反応時間と負の相関。転倒識別のAUCは指標間で差なし。 出典 理学療法科学 ↗

〈事例〉 **ADOCで依存的な生活が変化**
回復期脳卒中の1例。プラモデル作りを軸に、ADL・抑うつ・作業満足度が改善。 出典 作業療法の実践と科学 ↗